

Avance 2

Caso clínico 7

Grupo 12



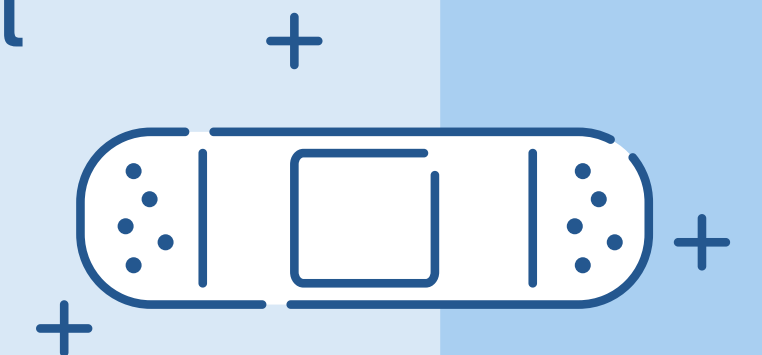
DATOS PERSONALES:

NOMBRE: LSA

Edad: 21 años

Procedencia: Lima

Motivo de ingreso: Rehabilitación integral



Estado del paciente

RIGHT

MOTOR
KEY MUSCLES

SENSORY
KEY SENSORY POINTS
Light Touch (LTR) Pin Prick (PPR)

ER
emy Right)

ents (Non-key Muscle? Reason for NT? Pain? / condition?):

RIGHT TOTALS
(MAXIMUM)

(50)

(56)

(56)

1. SENSORY

2. MOTOR

3. NEUROLOGICAL
LEVEL OF INJURY
(NLI)

T9

4. COMPLETE OR INCOMPLETE?

Incomplete = Any sensory or motor function in S4-5

5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS)

B

6. ZONE OF PARTIAL
PRESERVATION

Most caudal levels with any innervation

ROLOGICAL
LEVELS

6 for classification
: on reverse

RIGHT

MOTOR
KEY MUSCLES

SENSORY
KEY SENSORY POINTS
Light Touch (LTR) Pin Prick (PPR)

ER
emy Right)

ents (Non-key Muscle? Reason for NT? Pain? / condition?):

RIGHT TOTALS
(MAXIMUM)

(50)

(56)

(56)

1. SENSORY

2. MOTOR

3. NEUROLOGICAL
LEVEL OF INJURY
(NLI)

T9

4. COMPLETE OR INCOMPLETE?

Incomplete = Any sensory or motor function in S4-5

5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS)

B

6. ZONE OF PARTIAL
PRESERVATION

Most caudal levels with any innervation

ROLOGICAL
LEVELS

6 for classification
: on reverse

LEFT

MOTOR
KEY MUSCLES

SENSORY
KEY SENSORY POINTS
Light Touch (LTL) Pin Prick (PPL)

UEL
(Upper Extremity Left)

OTOR
(SCORING ON REVERSE SIDE)

0 = Total paralysis
1 = Palpable or visible contraction
2 = Active movement, gravity eliminated
3 = Active movement, against gravity
4 = Active movement, against some resistance
5 = Active movement, against full resistance
NT = Not testable
0*, ..., 4*, NT* = Non-SCI condition present

SENSORY
(SCORING ON REVERSE SIDE)

0 = Absent NT = Not testable
1 = Altered 0*, 1*, NT* = Non-SCI
2 = Normal condition present

LEFT TOTALS
(MAXIMUM)

(50)

(56)

(56)

1. SENSORY

2. MOTOR

3. NEUROLOGICAL
LEVEL OF INJURY
(NLI)

T9

4. COMPLETE OR INCOMPLETE?

Incomplete = Any sensory or motor function in S4-5

5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS)

B

6. ZONE OF PARTIAL
PRESERVATION

Most caudal levels with any innervation

ROLOGICAL
LEVELS

6 for classification
: on reverse

RIGHT

MOTOR
KEY MUSCLES

SENSORY
KEY SENSORY POINTS
Light Touch (LTR) Pin Prick (PPR)

ER
emy Right)

ents (Non-key Muscle? Reason for NT? Pain? / condition?):

RIGHT TOTALS
(MAXIMUM)

(50)

(56)

(56)

1. SENSORY

2. MOTOR

3. NEUROLOGICAL
LEVEL OF INJURY
(NLI)

T9

4. COMPLETE OR INCOMPLETE?

Incomplete = Any sensory or motor function in S4-5

5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS)

B

6. ZONE OF PARTIAL
PRESERVATION

Most caudal levels with any innervation

ROLOGICAL
LEVELS

6 for classification
: on reverse

LEFT

MOTOR
KEY MUSCLES

SENSORY
KEY SENSORY POINTS
Light Touch (LTL) Pin Prick (PPL)

UEL
(Upper Extremity Left)

OTOR
(SCORING ON REVERSE SIDE)

0 = Total paralysis
1 = Palpable or visible contraction
2 = Active movement, gravity eliminated
3 = Active movement, against gravity
4 = Active movement, against some resistance
5 = Active movement, against full resistance
NT = Not testable
0*, ..., 4*, NT* = Non-SCI condition present

SENSORY
(SCORING ON REVERSE SIDE)

0 = Absent NT = Not testable
1 = Altered 0*, 1*, NT* = Non-SCI
2 = Normal condition present

LEFT TOTALS
(MAXIMUM)

(50)

(56)

(56)

1. SENSORY

2. MOTOR

3. NEUROLOGICAL
LEVEL OF INJURY
(NLI)

T9

4. COMPLETE OR INCOMPLETE?

Incomplete = Any sensory or motor function in S4-5

5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS)

B

6. ZONE OF PARTIAL
PRESERVATION

Most caudal levels with any innervation

ROLOGICAL
LEVELS

6 for classification
: on reverse

LOWER EXTREMITY NEUROLOGIC EXAMINATION

The diagram illustrates the lower extremity neurologic examination. It includes a grid of tests for Motor, Reflex, and Sensation, each linked to specific nerve roots (L2-L5, S1-S5). A central diagram of the spine shows the corresponding nerve root levels for each test.

Motor	Reflex	Sensation	Nerve Root
Tibialis anterior	Patellar tendon	L4	L4
Extensor digitorum longus	None	L5	L5
Peroneus longus and brevis	Achilles tendon	S1	S1
Clening of toes	Anal "wink"	S2 to S5	S2 to S5

0	0	L2 Hip flexors
0	0	L3 Knee extensors
0	0	L4 Ankle dorsiflexors
0	0	L5 Long toe extensors
0	0	S1 Ankle plantar flexors

Usuario/Paciente: Habilidades y capacidades de la persona con discapacidad

Estado neuromuscular y musculoesquelético

- Pérdida de movimiento/sensibilidad en miembros inferiores (paraplejia)
- POSTURA: Control del tronco le permite tener estabilidad en su silla de ruedas
- CONTROL MOTOR:
Fuerza y manejo completo de miembros superiores (intactos):
 - Propulsión en silla de ruedas ✓
 - Traslados/cambios de posición ✓
 - Movimientos adaptativos con brazos ✓
- INFLUENCIA NEUROLÓGICA:
Algunos eflejos conservados en miembros inferiores:
 - ROT patelar izq.: Disminuido
 - Reflejo aquileo bilateral
 - Reflejo perianal

*No hay contracción voluntaria del esfínter anal
- MUSCULATURA: Disminuida en miembros inferiores

Usuario/Paciente: Habilidades y capacidades de la persona con discapacidad

Estado neuromuscular y musculoesquelético

- PERCEPCIÓN SENSORIAL: Ausente en miembros inferiores y S4-S5 (región sacra).

→ Mayor propensión a sufrir lesiones por presión de no tomar cambios posturales

- Dolor/molestias en espalda o brazos por mecanismos adaptativos

Desempeño funcional

- Tiene independencia en sus actividades, no requiere asistencia parcial/total

→ Alimentación ✓

→ Vestirse ✓

→ Traslados ✓

- Rutina y actividades físicas
- Aseo y manejo de evacuaciones
- Horas al día en silla/cama

Usuario/Paciente:
Habilidades y
capacidades de la
persona con
discapacidad

Afecciones a la piel

- Antecedente de lesión por presión

Estado psicosocial

- Está completamente lúcido
- Puede comunicarse
- Motivación, tolerancia a la tecnología
- Conciencia de seguridad

Guía Técnica: Protocolo de Atención en Rehabilitación Integral de la Lesión de la Médula Espinal



Evaluación Integral Multidisciplinaria

Clasificación neurológica (ASIA), evaluación del tono muscular, evaluación articular, función respiratoria, control postural

Análisis de criterios para la Selección de Ejercicios

Nivel de Lesión (tetraplejía y paraplejía), Fase de rehabilitación, preservación motora

Aplicación Práctica del Programa de Ejercicios

Diversas categorías (reeducación respiratoria, movilización, fuerza y resistencia, destrezas)

Prevención y Educación para el Hogar

Reinserción a la vida cotidiana



Ejercicios de acuerdo al caso

FORTALECIMIENTO DE MIEMBROS SUPERIORES

- Pulsaciones en Silla de Ruedas
- Remo Sentado con Bandas de Resistencia
- Prensa de Pecho y Hombros

ESTABILIDAD DE TRONCO Y "CORE"

- Inclinationes de Tronco en Colchoneta o Silla
- Lanzamiento de Balón Ligero

TRANSFERENCIAS Y DESTREZAS FUNCIONALES

- Práctica de transferencias
- Manejo activo de las sillas de ruedas

ESTIRAMIENTOS Y MOVILIDAD PASIVA

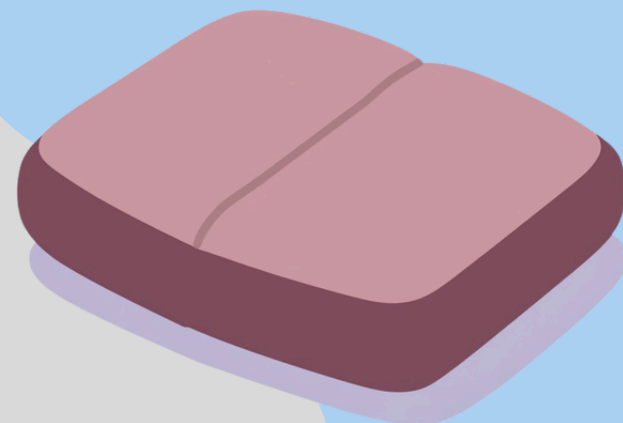
- Movilización Pasiva de Cadera, Rodilla y Tobillo
- Estiramientos Sostenidos de Isquiotibiales y Flexores de Cadera:

REEDUCACIÓN ESFINTERIANA

- Cateterismo Intermitente Limpio (CIL)
- Pauta de líquidos

Actividades

Debido a la gravedad de la lesión y un pronóstico de rehabilitación clasificación Bueno (TORZO). El paciente debe comprometerse a seguir estándares de actividades monitoreadas e intermitentes por la falta de control total.

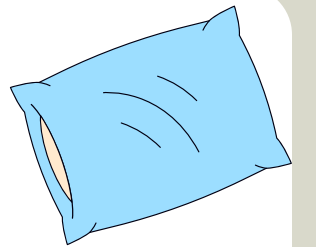


01



Frecuencia de ejercicios
de cambio postural
(inclinación 20-30 grados)
- ÚLCERA SACRA

02



Uso de cojines de
restricción de
presión

03



Incorporación de
cateterismo
intermitente

04



Rigidez muscular
por la falta de
movimiento

05



Actividades del hogar y trabajo.
Un antes y un después del accidente.



PREGUNTAS FORMULADAS

i) ¿Con qué frecuencia exacta el paciente realiza descargas de peso en su silla de ruedas y logra adoptar posturas de lado (decúbito lateral a 20-30 grados) al estar en la cama para el cuidado de la úlcera sacra?

ii) Durante el uso diario de la silla de ruedas, ¿el paciente logra mantener las rodillas a 90 grados y utiliza cojines de redistribución de presión para evitar nuevas lesiones en la piel?

iii) ¿Qué ejercicios físicos diarios ejecuta orientados específicamente a lograr transferencias independientes (por ejemplo, de la cama a la silla), impulsar su silla de ruedas y usar sus extremidades superiores?

iv) ¿Qué movimientos o terapias aplica en el día a día para tratar la rigidez leve y prevenir contracturas musculares en los dedos de los pies o en las extremidades inferiores?

06



Barreras
infraestructurales
del paciente en su
entorno diario



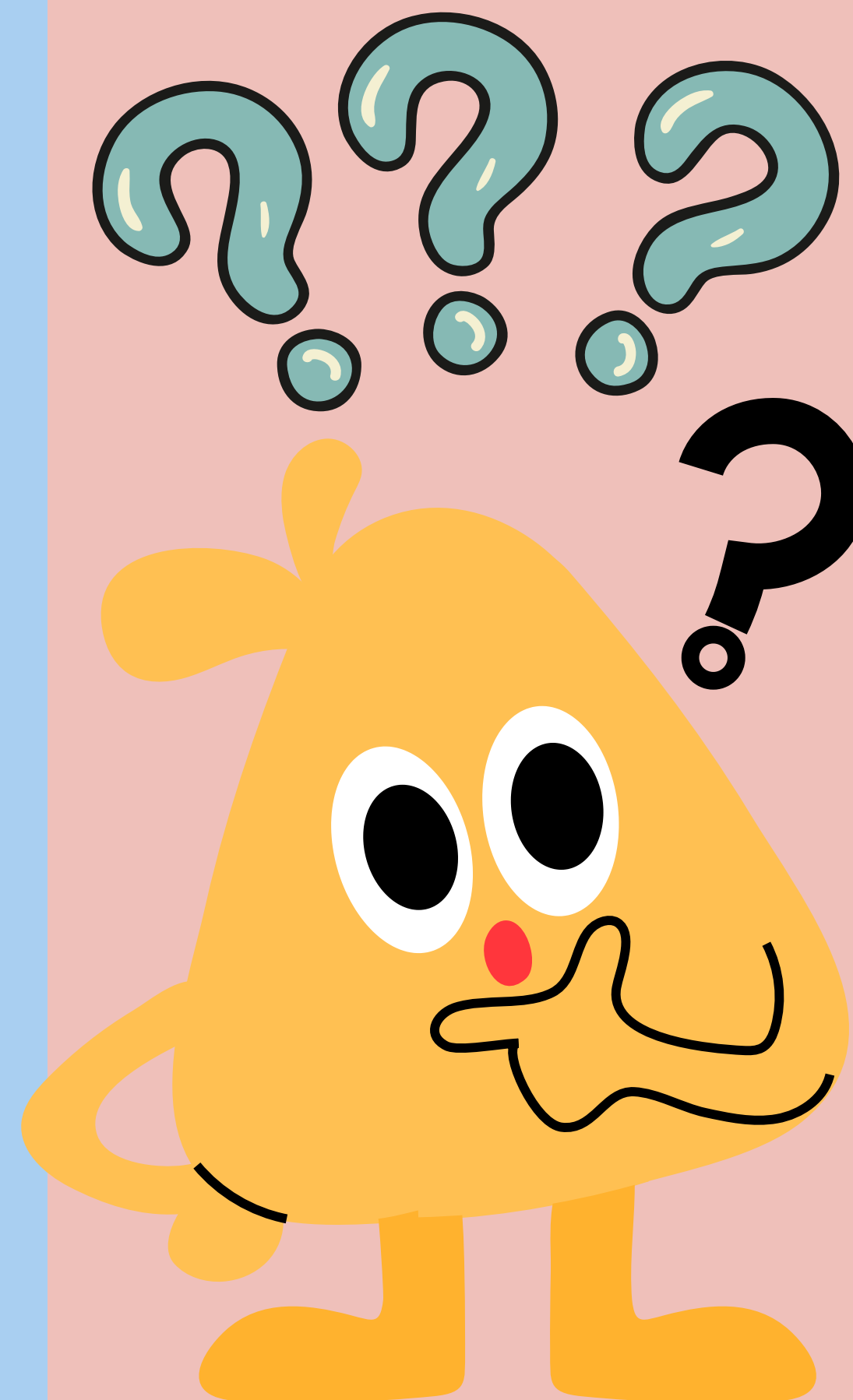
PREGUNTAS FORMULADAS

- v) Debido a la falta de movilidad y sensibilidad por debajo del nivel T9, ¿qué pasos exactos de su rutina de vestido y aseo personal requieren ayuda física de otra persona?
- vi) ¿El paciente incorpora el uso de prendas preventivas, como medias de compresión, durante sus actividades diarias para mejorar la circulación y evitar riesgos de trombosis en las piernas?
- vii) De las tareas académicas, laborales o del hogar que realizaba antes del traumatismo, ¿cuáles ejecuta actualmente y qué modificaciones físicas específicas requirió su entorno para poder hacerlas?
- viii) ¿Qué actividades específicas realiza el paciente fuera de su domicilio y qué barreras arquitectónicas o físicas encuentra en su entorno al intentar trasladarse en esos espacios?



Preguntas restantes

- i) ¿De qué manera incorpora el paciente el procedimiento de cateterismo intermitente limpio dentro de su rutina diaria de higiene para lograr el vaciado de su vejiga?
- ii) Considerando el diagnóstico de intestino neurogénico, ¿qué tareas o rutina específica debe realizar diariamente el paciente (o su cuidador) para el manejo de sus evacuaciones?
- vi) ¿Qué movimientos o terapias aplica en el día a día para tratar la rigidez leve y prevenir contracturas musculares en los dedos de los pies o en las extremidades inferiores?
- vii) ¿Qué pasos exactos de su rutina de vestido y aseo personal requieren ayuda física de otra persona?
- viii) ¿El paciente incorpora el uso de prendas preventivas, como medias de compresión, durante sus actividades diarias para mejorar la circulación y evitar riesgos de trombosis en las piernas?
- ix) De las tareas académicas, laborales o del hogar que realizaba antes del traumatismo, ¿cuáles ejecuta actualmente y qué modificaciones físicas específicas requirió su entorno para poder hacerlas?
- x) ¿Qué actividades específicas realiza el paciente fuera de su domicilio y qué barreras arquitectónicas o físicas encuentra en su entorno al intentar trasladarse en esos espacios?



Tecnología:

Dispositivos:



Silla de ruedas estándar



Conjín de espuma prensada con glicina

Estrategias:



Reeducación para descomprimir el área de manera autónoma

Posee posiciones recomendadas para sus miembros inferiores



Gracias